

1. Пацієнт віком 27 років скаржиться на тягуче, ниюче, неприємне відчуття в животі, заявляє, що кишечник перевертається та шлунок ніби опустився донизу. Просить повторно пройти УЗД, але в іншій лікарні. Скаржиться, що його обстежував некомпетентний лікар. Який розлад спостерігається в пацієнта?

- A. Іпохондрія
- B. Вісцеральні галюцинації
- C. Псевдогалюцинація
- D. Сенестопатія
- E. Маячна ідея відношення

2. Пацієнтка віком 86 років останній рік спостерігається у психіатра з діагнозом: деменція при хворобі Альцгеймера з пізнім початком. За словами доньки, протягом останнього тижня стала агресивною, перестала спати вночі, звинувачує її в тому, що вона краде її речі, забирає у неї гроші та не дає їй їсти. Кликнула на допомогу сусідів, просила викликати поліцію, оскільки донька, на її думку, пускає отруйний газ у кімнату, хоче її заморити голодом та вбити, щоб заволодіти її квартирою. Який препарат буде засобом вибору для лікування цього стану?

- A. Аміназин
- B. Левомепромазин
- C. Клозапін
- D. Амісульприд
- E. Рисперидон

3. До лікаря-психіатра звернулася мати дівчини віком 14 років зі скаргами на переживання страху, сорому і почуття незручності у дитини в присутності інших. Дівчина соромиться в присутності сторонніх користуватися туалетом, відповідати на питання викладачів у класі. Намагається уникати перебування в центрі уваги, боїться глузувань. Укажіть психопатологічний розлад.

- A. Соціальна фобія
- B. Панічний
- C. Тривожний
- D. Агорафобія
- E. Адаптації

4. Пацієнтку віком 30 років психіатризовано у зв'язку з психомоторним збудженням, маячними ідеями особливого значення, агресивністю, дратівливістю та неадекватністю в поведінці (викидала речі з вікна власної квартири, а також трансливала численні прямі ефі-

ри в одній із соціальних мереж, на яких безперестанку танцювала). Який лікарський засіб буде препаратом вибору з огляду на те, що пацієнтка хворіє на аденому аденогіпофізу?

- A. Кветіапін
- B. Галоперидол
- C. Сульпірид
- D. Рисперидон
- E. Паліперидон

5. Пацієнт віком 33 роки, стоячи у кутку палати, без будь-якої причини починає стереотипно присідати, хитати головою та тулубом, повторюючи за всіма, хто навколо, їхні слова та фрази. Прохань та інструкцій персоналу не виконує, під час спроби покласти його на ліжко став агресивним. Який стан спостерігається у пацієнта?

- A. Істеричне збудження
- B. Ажитована депресія
- C. Маніакальне збудження
- D. Кататонічне збудження
- E. Гебефренічне збудження

6. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на часте вживання нового синтетичного наркотику, який призводив до ейфорії, гіперактивності та швидкої стомлюваності. Під час огляду виявлено: психомоторне збудження, тахікардія. Позитивний аналіз сечі на катинони. Який терапевтичний підхід буде найбільш ефективним?

- A. Антидот до катинонів
- B. Антипсихотики для контролю збудження
- C. Бензодіазепіни для контролю збудження
- D. Антидепресанти для зниження ейфорії
- E. Інтенсивна гідратація та симптоматичне лікування

7. До лікаря-психіатра звернулися батьки п'ятирічного хлопчика зі скаргами на затримку розвитку мовлення, відсутність зацікавленості до гри з однолітками, дивакувату поведінку — одноманітне повторювання рухів головою, почуття слів, не відповідає на питання, які чує. Не підтримує зоровий контакт, надмірно боязливий у новій обстановці, не реагує на прості вказівки, на звертання до нього, хоча в дитини немає проблем зі слухом. Який найімовірніший діагноз?

- A. Розлади емоцій та поведінки
- B. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності
- C. Психічний інфантилізм
- D. Розлади аутистичного спектра
- E. Розумова відсталість

8. Група з шести підлітків курить цигарки. Через 10 хв стають веселими, голосно сміються, незважаючи на подив перехожих, гримасують, стрибають. У трьох виникло відчуття, що гілки дерев під ногами перетворилися на величезні колоди. Це спричинило новий вибух реготу. Який наркотик вживали підлітки?

- A. Крек
- B. Марихуану
- C. Амфетамін
- D. Екстазі
- E. ЛСД

9. Шестирічна дитина з розладом аутистичного спектра, сидячи в автомобільному кріслі, у спокійному настрої розмахує руками та ногами у різні боки, з власної волі час від часу припиняє здійснювати ці рухи. Яку назву має вказаний прояв?

- A. Хорея
- B. Парціальні судомні напади
- C. Стимінг
- D. Тахікінезі
- E. Тики

10. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано з приводу інфаркту міокарда. Через два дні після шпиталізації він прокидається серед ночі і кричить, що біля вікна в його кімнаті стоїть чоловік. Коли медсестра входить до кімнати і вмикає світло, пацієнт із полегшенням дізнається, що «людина» насправді була завісою біля вікна. Який із нижченаведених психіатричних термінів найкраще описує це неправильне сприйняття реальності?

- A. Галюцинації
- B. Омана
- C. Ілюзія
- D. Проекція
- E. Деменція

11. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на знижений настрій, страх, тривогу, безсоння, песимістичні думки, втрату зацікавленості, складність у зосередженні уваги, відчуття загальмованості. Симптоматика наростала впродовж останніх трьох тижнів, виникала 1-2 рази на рік упродовж останніх 5 років,

переважно в осінньо-весняний період. Для якого патологічного стану характерна така симптоматика?

- A. Депресивного епізоду помірного ступеня
- B. Рекурентного депресивного розладу
- C. Депресивного розладу із психотичними симптомами
- D. Шизофренії
- E. Маніакального епізоду

12. Який розлад не належить до дисоціативних розладів?

- A. Амнезія
- B. Одержимість
- C. Фуга
- D. Іпохондрія
- E. Розлад множинної особистості

13. Пацієнт віком 14 років не засвоює шкільну програму, особливо з математики. Мовлення фразове — у 4 роки, у дитячому садку був проблемний у поведінці, ламав іграшки. Ледве читає по складах, не може розв'язати прості задачі, не розуміє сенс простих прислів'їв і приказок. Закінчив лише 2 класи школи, повільний. В анамнезі: родова травма. Який найімовірніший діагноз?

- A. Шизофренія
- B. Розумова відсталість
- C. Депресивний розлад
- D. Затримка розвитку
- E. Розлад спектра аутизму

14. У підлітка, вихованця інтернату віком 14 років, під час проведення МРТ головного мозку було виявлено зменшений у розмірах гіпокамп. З анамнезу відомо: має порушення сну та порушення поведінки — неслухняний, агресивний, погано вчиться, прогулює уроки, обманює, почав курити. Необережний, двічі мало не потрапив під машину. Ображає інших вихованців. Чим, найімовірніше, спричинена вказана симптоматика?

- A. Антисоціальним розладом особистості
- B. Хронічним насильством у дитинстві
- C. Розладом спектра аутизму
- D. Шизоафективним розладом
- E. Біполярним афективним розладом

15. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на депресію, тривогу, порушення сну, періодичну булімію, які тривають ще з раннього підліткового віку. За останні 5 років змінила кілька психоте-

рапевтів, приймала різні медикаменти, однак суттєвого покращення не відчувала. Пацієнтка привертає увагу яскравим фарбованим волоссям, татуюваннями, неохайним одягом. Наносить собі пошкодження (припікає до шкіри цигарки, ріже лезом шкіру на передпліччях), періодично зловживає ПАР, часто змінює сексуальних партнерів та місце роботи, пояснюючи це тим, що не може знайти спільну мову з колективом або ж організувати час так, щоб встигати виконувати свої обов'язки. Який найімовірніший діагноз?

- А. Залежний розлад особистості
- В. Антисоціальний розлад особистості
- С. Межовий розлад особистості
- Д. Істеричний розлад особистості
- Е. Ананкастний розлад особистості

16. До лікаря-психіатра звернувся молодий чоловік віком 37 років зі скаргами на тривале зниження настрою, головний біль, біль у животі. Не одружений, працює програмістом. Лікарем гастроентеролог виключив соматичну патологію. Характеризується відсутністю інтересу до близьких стосунків як у сім'ї, так і в інших міжособистісних відносинах, включаючи інтимні/сексуальні стосунки. Об'єктивно спостерігається: емоційно холодний, відчужений. Визначте наявний розлад особистості в пацієнта.

- А. Шизоїдний
- В. Ананкастний
- С. Астенічний
- Д. Параноїдний
- Е. Істеричний

17. Пацієнтку віком 68 років шпиталізовано до лікарні через агресію до рідних. Скарги на самопочуття не висловлює. Стверджує, що донька, яка за нею доглядає, «декілька років краде все з дому», «зовсім не дає їсти, забирає пенсію». Донька повідомляє, що пацієнтка має погіршення пам'яті. Тест MMSE — 18 балів. Визначте оптимальний препарат для лікування агресії.

- А. Хлорпротиксен
- В. Рисперидон
- С. Оланзапін
- Д. Галоперидол
- Е. Хлорпромазин

18. Пацієнта віком 52 роки направили до лікаря-психіатра після отримання дисциплінарного стягнення на роботі у

зв'язку з постійним невчасним поданням звітів. Він наполягає на тому, що не збирається нічого здавати, поки це не буде «ідеально, на відміну від усіх його колег», та відмовляється вірити, що проблеми мають щось спільне з його особистою поведінкою. У нього мало друзів через те, що він дратує їх своєю вимогливістю до «точної своєчасності» і відсутністю душевного тепла. Який найімовірніший діагноз?

- А. Тривожний розлад, не уточнений іншим чином
- В. Біполярний розлад, змішаний стан
- С. Депресивний розлад
- Д. Обсесивно-компульсивний розлад особистості
- Е. Емоційно нестабільний розлад особистості

19. Пацієнтка віком 28 років, внутрішньо переміщена зі Сходу України, скаржиться на складність процесу засинання, наявність звуків «ніби летить ракета», страх лягати спати, прискорене серцебиття, коливання АТ, відчуття постійної тривоги протягом дня, яка посилюється ближче до вечора. Із анамнезу відомо, що симптоми виникли 3 тижні тому, коли під час повітряної тривоги влучила ракета у будинок, а вона при цьому не пішла з дітьми в укриття, хоча постійно це попередньо робила. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- А. Шизофренія
- В. Специфічна фобія
- С. Панічний розлад
- Д. Розлад адаптації пов'язаний зі стресом, у вигляді тривожно-фобічного синдрому
- Е. Інсомнія

20. Пацієнт віком 22 роки протягом останніх 6-ти місяців став замкненим, почав розмовляти сам із собою. Під час психіатричного огляду повідомляє, що чує «голоси», які лунають у його голові та грудях. Сприймає «голоси» як нереальні, пугучі. Інтенсивність «голосів» залишається однаковою протягом доби. Які розлади сприйняття можна припустити у пацієнта?

- А. Метаморфопсії
- В. Псевдогалюцинації
- С. Дерезалізація
- Д. Ілюзії
- Е. Справжні галюцинації

21. Пацієнт віком 21 рік, анамнез не обтяжений. Вперше шпиталізований до

закладу з надання психіатричної допомоги з дому у стані сильного психічного та рухового збудження. Кричить, намагається покинути палату, розмовляє сам із собою, часом замовкає і прислуховується до чогось. Фізичний та неврологічний стан пацієнта в нормі. Препарати якої групи доцільно призначити?

- ☐ А. Снодійні
- ☐ В. Нейротропи
- ☐ С. Нормотиміки
- ☐ Д. Антипсихотики
- ☐ Е. Антидепресанти

22. До лікаря-психіатра звернулася матір із десятирічною дитиною зі скаргами на почастищення судомних нападів і зміни поведінки з ознаками своєрідних змін рис характеру дитини. Хлопчик став дратівливим, запальним, злісним, причіпливим, егоцентричним, разом із цим, може бути занадто ввічливим, улесливим, педантичним. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Розумова відсталість
- ☐ В. Органічні розлади у дітей та підлітків
- ☐ С. Психотичні розлади у дітей та підлітків
- ☐ Д. Афективні розлади у дітей та підлітків
- ☐ Е. Епілепсія у дітей та підлітків

23. Пацієнт віком 30 років з діагнозом: параноїдна шизофренія — неодноразово лікувався в психіатричному стаціонарі. Під час останнього загострення приймав рисперидон 6 мг протягом 4-х тижнів без видимого ефекту, та оланзапін 20 мг протягом 4-х тижнів без видимого ефекту. Було прийнято рішення про визначення в пацієнта терапевтичної резистентності. Який лікарський засіб на цей момент буде доцільно призначити пацієнту?

- ☐ А. Ламотриджин
- ☐ В. Кветіапін
- ☐ С. Хлорпромазин
- ☐ Д. Галоперидол
- ☐ Е. Клозапін

24. Чоловіка віком 41 рік шпиталізовано до психіатричного стаціонару з виправного закладу через погіршення психічного стану: став напруженим, збудливим, не спав вночі, вважав, що проти нього змовилися наглядачі та інші ув'язнені. 3-4 роки тому звернув увагу на «заплітання язика», посіпування м'язів обличчя. Через 2 роки поруши-

лася хода, стала розмашистою, з'явилися неконтрольовані рухи кінцівок. На момент огляду виявлено асиметричні гіперкінези м'язів обличчя. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Хвороба Гентінгтона
- ☐ В. Шизоафективний розлад
- ☐ С. Нейролентичний синдром
- ☐ Д. Хвороба Паркінсона
- ☐ Е. Епілепсія

25. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, дається, заявляє, що все це робить не вона, а вчитель, який опанував її волю та керує. Вона знає, що говорить і робить «непотрібне», але це тому, що в її гортані є щось стороннє: «моя гортань підкорена чужій волі». Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Маніакальний епізод
- ☐ В. Циклотимія
- ☐ С. Дитяча шизофренія
- ☐ Д. Органічний маячний розлад
- ☐ Е. Гострий поліморфний психотичний розлад

26. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на часті епізоди переїдання, після яких вона викликає блювання або вживає проносні засоби, щоб уникнути збільшення ваги. Такі епізоди виникають принаймні двічі на тиждень упродовж останніх шести місяців. Зазвичай, це відбувається після стресових ситуацій або коли вона почувається тривожною. Епізоди переїдання викликають у неї значне відчуття провини, але вона не може контролювати їх. Який патологічний стан спостерігається у пацієнтки?

- ☐ А. Нервова анорексія
- ☐ В. Нервова булімія
- ☐ С. Орторексія
- ☐ Д. Компульсивне переїдання
- ☐ Е. Психогенне переїдання

27. Пацієнтку віком 16 років направлено на консультацію до лікаря-психіатра у зв'язку з аменореєю та низькою вагою (індекс маси тіла — 16). Мати дівчини стверджує, що протягом останнього року дівчина почала дотримуватися суворої дієти, обмежувала себе у вживанні води та постійно виснажувала фізичними заняттями. Минулого тижня мати знайшла у дівчини діуретичні препарати. Дівчина заперечує наявність проблеми і заявляє, що в неї не-

має жодного дефіциту ваги. Який імовірний розлад у пацієнтки?

- A. Нервова анорексія**
- B. Посттравматичний стресовий розлад**
- C. Шизофренія**
- D. Розлад відсутній, вікова норма**
- E. Обсесивно-компульсивний розлад**

28. Пацієнтка віком 37 років, яка перший раз звернулася до лікаря-психіатра, скаржиться на загальну слабкість, неможливість виконувати повсякденні справи, відсутність апетиту (схудла на 4 кг за місяць), байдужість до інших та свого зовнішнього вигляду, а також на проблеми з нічним сном. Який найімовірніший діагноз?

- A. Шизофренія**
- B. Тривожно-депресивний розлад**
- C. Біполярний афективний розлад**
- D. Неврастенія**
- E. Депресивний розлад**

29. Чоловік віком 42 роки постійно відчуває втому та відсутність зацікавленості у щоденній діяльності. Скаржиться на помірно знижений настрій, труднощі із засинанням та ранні пробудження, зниження апетиту, відчуття внутрішнього дискомфорту. Пацієнт продовжує працювати та займатися побутом, зрідка проводить час, займаючись хобі, але це не приносить йому задоволення. Цей стан триває протягом двох років і не змінюється на маніакальні або гіпоманіакальні епізоди. Який найімовірніший діагноз?

- A. Змішаний тривожно-депресивний розлад**
- B. Циклотимія**
- C. Рекурентний депресивний розлад**
- D. Біполярний афективний розлад**
- E. Дистимія**

30. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на безсоння, бачить, «як по стінах лазять павуки». Із анамнезу відомо, що зловживає алкоголем з 19-ти років, але не пив останні 3 дні. Об'єктивно спостерігається: тремтить, йому важко розповідати про те, що трапилося, АТ — 170/95 мм рт. ст., ЧСС — 100/хв, пітливість. Який найімовірніший діагноз?

- A. Алкогольний абстинентний делірій**
- B. Алкогольне сп'яніння**
- C. Психотичний розлад, спричинений алкоголем**
- D. Психоз Верніке**
- E. Алкогольна ідіосинкратична інтоксикація**

31. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на нестабільність настрою, відчуття порожнечі та невпевненості в собі. Розповідає, що з підліткового віку вона має нестійкі відносини з близькими та всіма навколо, періодично має депресію або відчуває епізоди гніву та агресії. Описує епізоди самоушкодження, зокрема різання себе з метою «заглушити душевний біль фізичним болем». Відзначає часту швидку зміну партнерів, оскільки швидко розчаровується в них, водночас відчуває страх залишитися самотньою. Який розлад особистості спостерігається в пацієнтки?

- A. Межовий**
- B. Унікаючий**
- C. Демонстративний**
- D. Параноїдний**
- E. Шизоїдний**

32. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на сильну тривогу та страх бути в людних місцях, зокрема в торгових центрах, громадському транспорті та великих зібраннях людей. Через цей страх уникає виходу з дому, і навіть купівля продуктів стає проблемою, змушений замовляти доставку. Під час виходу на вулицю відчуває серцебиття, задишку, тремтіння, нудоту та панічні атаки. Укажіть препарати вибору для фармакотерапії цього розладу.

- A. Інгібітори моноамінооксидази**
- B. β -блокатори**
- C. Трициклічні антидепресанти**
- D. Інгібітори зворотного захоплення норадреналіну і дофаміну**
- E. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну**

33. Пацієнт віком 28 років скаржиться на безсоння, нудоту, блювання та страх. Об'єктивно спостерігається: пацієнт дезорієнтований у місці та часі, орієнтований у власній особі, неспокійний, зривається з місця, ховається під ліжко та бачить навколо себе «чорних жуків», яких топче ногами. Із анамнезу відомо, що зловживає алкоголем. Яке лікування є найбільш доцільним?

- A. Діазепам + детоксикація
- B. Антидепресанти + пренарати літію
- C. Галоперидол + форсований діурез
- D. Анксіолітики + психотерапія
- E. Електроконвульсивна терапія

34. Військовослужбовця віком 29 років шпиталізовано до лікарні. Відомо, що він брав участь в активних бойових діях протягом останніх двох років, бачив на власні очі загибель побратимів. Був у супроводі родичів, які розповіли, що під час вечері вдома через відчинене вікно долинув звук гуркоту трамваю, який проїжджав, після цього пацієнт раптом встав зі стільця, сховався за шафу та кричав до них: «Ховайтеся, зараз буде обстріл!». Зі слів пацієнта, шум трамваю спровокував появу стану, ніби він знаходиться на полі бою під загрозою арт-обстрілу. Після цього він відчув страх, жах, сильне серцебиття, перехоплення подиху. Яке психічне явище виникло в пацієнта?

- A. Сутінкове потьмарення свідомості
- B. Наркотичне сп'яніння
- C. Флешбек
- D. Панічна атака
- E. Галюцинації

35. Пацієнт віком 62 роки до кабінету зайшов невпевненою човгаючою ходою. Висловлює скарги на біль у м'язах, тремор у стані спокою, схильність до падінь, зниження пам'яті, труднощі під час запам'ятовування нової інформації, при згадуванні минулих подій, зниження концентрації уваги, порушення сну, ілаксивність, зміни настрою. Під час обстеження говорить тихим монотонним голосом, періодично замилюється, замовкає, міміка збідніла, визначається ригідність м'язів за типом зубчастого колеса. Укажіть причину нейрокогнітивного розладу.

- A. Хвороба Паркінсона
- B. Фронтально-темпоральне ушкодження
- C. Хвороба Гентінгтона
- D. Тільця Леві
- E. Черепно-мозкова травма

36. Пацієнт віком 47 років лікується у психіатричному стаціонарі з приводу зловживання алкогольними напоями. Відомо, що останній раз алкоголь вживав «запійно» 8 днів поспіль, востаннє 3 дні тому. Під час огляду виявлено: дезорієнтований у часі та місці перебування, говорить, що перебуває в себе вдома, намагається агресивно з'ясува-

ти, чому по його кімнаті бігають ящірки, зі слів медичного персоналу, останні 2 доби спостерігалось безсоння. Об'єктивно спостерігається: тремор кінцівок, пітливість, артеріальна гіпертензія, тахікардія. Препарати якої групи потрібно застосувати для седації пацієнта?

- A. Антидепресанти з седативною дією
- B. Транквілізатори
- C. Антипсихотики
- D. Снодійні препарати
- E. Гіпнотики

37. Укажіть симптоми, які не пов'язані з нейрокогнітивними розладами.

- A. Гіпоманія
- B. Короточасна втрата пам'яті
- C. Делірій
- D. Атрофія кори головного мозку
- E. Дратівливість

38. Пацієнтка віком 35 років повідомляє, що раніше двічі перебувала в депресивних станах тривалістю до 5-6 місяців. Наразі її турбує відсутність приємного їй задоволення від спілкування з близькими людьми (дітьми, чоловіком, батьками). Перестали радувати подарунки, компліменти, похвала. Зникла привабливість будь-яких матеріальних благ. У клінічній картині якої депресії спостерігаються такі симптоми?

- A. Депресії з маячними ідеями самозвиначення
- B. Депресії з обсесіями
- C. Тривожної
- D. Анестетичної
- E. Ажитованої

39. Пацієнт віком 30 років звернувся до лікаря-психіатра через те, що його звільнили за постійні запізнення на роботу. Стверджує, що відчуває небезпеку зараження мікробами, і тому змушений безперервно приймати душ, часто до восьми годин на день. Який нейромедіатор залучений до цього розладу?

- A. Ацетилхолін
- B. Дофамін
- C. Норадреналін
- D. Серотонін
- E. Гістамін

40. Пацієнт віком 26 років, який знаходиться на наркологічному обліку, з діагнозом: ППРВВ (синдром залежності внаслідок вживання опіоїдів) — скар-

житись на тремор у верхніх кінцівках, безсоння, ринорею, слюзотечу та дратівливість. Які лікувальні заходи є методом вибору лікування пацієнта з цим діагнозом?

- A. Введення анксиолітиків
- B. Детоксикація
- C. Рекомендація для пацієнта відмовитись від прийому опіоїдів
- D. Введення аміназину
- E. Довготривале медикаментозне лікування агоністами опіоїдів (ПТАО)

41. До лікаря-психіатра звернулася матір із донькою віком 15 років, яка вважає себе такою, що має зайву вагу, не подобається собі, відмовляється від прийому їжі, викликає у себе блювоту, п'є проносні засоби. Хочє, щоб її вага була не більше 37 кг при зрості 165 см. Який найімовірніший діагноз?

- A. Нервова анорексія
- B. Дисторфофобія
- C. Нервова булімія
- D. Шизофренія
- E. Дисоціативний розлад

42. Мати звернулася до дитячого психіатра через стереотипну поведінку та регрес мовлення свого шестирічного сина. З двох років мати помітила вибірковість у спілкуванні, порушення сну та вибірковість у їжі. У дитячому дошкільному закладі помічали відсутність вербального спілкування з іншими дітьми та вихователями, але збереження невербальних засобів комунікації. Психічний стан: зоровий контакт встановлюється на короткий час, емоційні реакції слабко диференційовані. Під час огляду виявляє стереотипну аутоагресію: щипає, кусає себе, намагається битися головою. Оберіть препарат для лікування аутоагресії.

- A. Брекспразол
- B. Оланзапін
- C. Каріпразин
- D. Зипразидон
- E. Рисперидон

43. Чоловік недалеко від зупинки громадського транспорту поводить себе агресивно, кричав, розмовляв сам до себе, намагався ловити «пацюків», що йому привиджалися. Сторонніми була викликана бригада Е(Ш)МД, чоловіка доставлено до психіатричного стаціонарного відділення. Анамнестично: зловживає алкоголем більше 10 років,

запійно, останнє вживання — 4 дні тому. Харчується нерегулярно, усі можливі кошти витрачає на алкоголь. Було введено розчин глюкози 5% 500 мл в/в крапельно, після чого у пацієнта виникли сплутаність свідомості, атаксія, офтальмоплегія. Введення якого препарату замість ізотонічного розчину глюкози могло б попередити виникнення ускладнень мозку?

- A. Тіаміну (вітамін B1)
- B. Аскорбінової кислоти (вітамін C)
- C. Кальцію глюконат
- D. Гіпертонічного розчину глюкози 40% 10 мл в/в струминно
- E. Розчину магнію сульфат 25% 10 мл в/м

44. Пацієнт віком 34 роки, учасник бойових дій, демобілізований у зв'язку з тяжким пораненням. Зі слів рідних, погано спить, вночі ходить по дому або ж раптово прокидається з голосним криком. Подразливий, легко збудливий, недовірливий. Більшість часу відсторонений, не виявляє позитивних емоцій навіть під час спілкування з власними дітьми. До контакту важкодоступний, неохоче вступає в бесіду з лікарем. Який клінічний опитувальник доцільно застосувати в цьому разі для покращення діагностичного процесу?

- A. Тест Роршаха
- B. MMPI
- C. PCL-5
- D. HADS
- E. MMSE за Фольштейном

45. Пацієнтка віком 43 роки уперше захворіла 20 років тому після пологів. Неодноразово лікувалася стаціонарно. Об'єктивно спостерігається: доступна до формального мовного контакту, незачесана, одяг неохайний, воліє бути на самоті. Скарг, побажань не висловлює, байдужа до навколишнього, час проводить бездіяльно. Який патологічний стан спостерігається в пацієнтки?

- A. Абулія
- B. Ступор
- C. Меланхолія
- D. Негативізм
- E. Слабкодухість

46. Під час огляду пацієнта віком 50 років виявлено: свідомість збережена, скарг не висловлює, ім'я лікаря не запам'ятав навіть після кількох повторень. Із анамнезу відомо, що зловживає ал-

коголем, тиждень тому мав порушення свідомості. Під час розпитування, де він був до епізоду порушення свідомості, сказав, що їхав на море, але раніше розповідав, що був на роботі. Настрій дещо підвищений, але подразливий. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ А. Корсаковський синдром
- ☐ В. Хвороба Альцгеймера
- ☐ С. Хвороба Гентінгтона
- ☐ D. Енцефалопатія Гайє-Верніке
- ☐ E. Хвороба Піка

47. У пацієнтки віком 29 років раптово підвищилася температура тіла, погіршилося самопочуття, стала сонливою, проспала майже три доби. Із анамнезу відомо, що 4 дні тому хворіла на ГРВІ. Скаржиться на відчуття тривоги, запаморочення, двоїння в очах, «викривлене бачення» навколишніх предметів, відчуття «невагомості». Об'єктивно спостерігається: птоз, ністагм, обличчя асиметричне, нестійка у позі Ромберга. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ А. Менінгококова інфекція
- ☐ В. Епідемічний енцефаліт
- ☐ С. Розсіяний склероз
- ☐ D. Генералізований тривожний розлад
- ☐ E. Сифіліс

48. Семирічний хлопчик під час занять у школі постійно розмовляє, відволікає інших учнів і не може дотримуватися інструкцій учителя. Також часто легко відволікається від своїх ігор та завдань удома, швидко переходячи від одного заняття до іншого без завершення попереднього. На огляді батьки повідомляють, що цей стан був майже завжди в дитини. Оберіть найбільш безпечний та ефективний препарат для лікування цього стану.

- ☐ А. Арипіразол
- ☒ В. Вальпроєва кислота
- ☐ С. Гідазепам
- ☐ D. Атомоксетин
- ☐ E. Гопантенова кислота

49. Жінка віком 32 роки після зради чоловіка і розлучення з ним щодня плакала, перестала їсти, схудла на 5 кг за 2 тижні, з'явилися безсоння, підвищена втомлюваність, знижена працездатність. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, критика збережена, депресивна. Говорить повільно. Який лікарський засіб доцільно призначити в цьому разі?

- ☐ А. Галоперидол
- ☐ В. Пароксетин
- ☒ С. Зуклопентиксол
- ☐ D. Арипіразол
- ☐ E. Мебікар

50. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, отриманого під час весілля доньки. На третій день пацієнт став агресивним, збудженим, тривожним. Наполягав на виписці, вважав, що він на м'ясокомбінаті і з нього хочуть зробити ковбасу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, АТ — 160/90 мм рт. ст., ЧСС — 110/хв. Із анамнезу відомо, що періодично має псевдозапої. Який лікарський засіб необхідно призначити у цьому разі?

- ☐ А. Тіамін
- ☐ В. Галоперидол
- ☐ С. Гідазепам
- ☒ D. Рисперидон
- ☐ E. Діазепам

51. Пацієнт віком 28 років звернувся до закладу з надання психіатричної допомоги вперше за направленням від сімейного лікаря. Скаржиться на частий головний біль, який з'явився декілька місяців тому, пavidку стомлюваність та голоси, які він чує ніби поряд із собою і яких не чує інші. Також з інтерв'ю пацієнта відомо, що останнім часом він бачить людей та тварин, яких насправді немає. Шкідливі звички, ЧМТ та вживання ПАР категорично заперечує. У психічному стані: орієнтований всебічно правильно, мислення та мовлення звичайні за темпом, формальних порушень мислення не виявлено. Дещо напружений, наляканий, тривожний, пам'ять та увага незначно знижені. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

- ☐ А. Призначення антидепресантів
- ☐ В. Призначення атипичних антипсихотиків
- ☒ С. Направити на МРТ ГМ з подальшою консультацією лікаря-невролога
- ☐ D. Направити на ЕЕГ
- ☐ E. Призначення анксіолітиків

52. Після тривалого прийому антипсихотика у пацієнтки виникли такі симптоми: порушення менструального циклу, галакторея, дискомфорт та біль у молочних залозах. Який лікарський засіб доцільно призначити для мінімізації побічних ефектів?

- A. Рисперидон
- B. Оланзапін
- C. Азалептол
- D. Арипіпразол
- E. Кветіапін

53. Пацієнтку віком 26 років чоловік привіз до лікарні після того, як вона почала кричати, що їй дзвонять діти, і впала в істерику. Чоловік стверджує, що 2 тижні тому двоє їхніх дітей загинули в автомобільній аварії, і з того часу дружина була збуджена, неорганізована, заявляла, що не буде їсти, адже вважає, що він отруїв їй їжу. Останні 2 дні не спала. Вважає, що медсестри у відділенні збираються завдати їй шкоди. Жінку заспокоюють і згодом відправляють додому. Через тиждень усі її симптоми стихають спонтанно. Який найімовірніший діагноз?

- A. Посттравматичний стресовий розлад
- B. Делірій
- C. Велика депресія з психотичними ознаками
- D. Короткий психотичний розлад
- E. Біполярний афективний розлад

54. Пацієнтка віком 19 років у супроводі матері звернулася до лікаря-психіатра з приводу потягу до виривання волосся на голові. Зі слів пацієнтки, бажання виривати волосся з'явилося кілька років тому на фоні тривалого психоемоційного навантаження. Після виривання волосся відчуває зменшення внутрішньої напруги. На волосистій частині голови — симетричні ділянки облісіння, шкіра у місцях облісіння незмінена. Встановлено діагноз: трихотиломанія. Яка терапія вибору для пацієнтки?

- A. Призначення селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну
- B. Когнітивно-поведінкова терапія, спрямована на зміну звичок
- C. Призначення оланзапіну
- D. Призначення N-ацетилцистеїну
- E. Електросудомна терапія

55. Після вживання 200 мл сурогатного алкоголю у чоловіка віком 34 роки з'явилися симптоми сп'яніння, задишка, біль у шлунку, блювання, судоми, погіршення зору, «білі плями» перед очима. Об'єктивно спостерігається: зіниці розширені, не реагують на світло, свідомість на момент огляду не порушена. Які лікувальні заходи є першочерговими в цьому разі?

- A. Введення унітіолу
- B. Проведення плазмаферезу
- C. Введення розчину етанолу
- D. Викликання блювання
- E. Введення атропіну сульфату

56. Пацієнт віком 56 років доставлений родичами на прийом до лікаря. Самостійно скарг не висловлює, мовному контакту мало доступний, відповідає одноманітними словами та фразами. Спокійний, коло інтересів звужене, виявлено виражене інтелектуально-мнестичне зниження. У часі та місці перебування не орієнтований, у власній особі орієнтований частково: плутає основні події життя, неправильно називає вік. За результатами МРТ: явища атрофії у лобній ділянці та менш виражені у скровених. Згідно з даними анамнезу: такий стан розвинувся протягом року, пацієнт звільнився з роботи декілька місяців тому. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ішемічний інсульт
- B. Хвороба Альцгеймера
- C. Хвороба Піка
- D. Деменція з тільцями Леві
- E. Пріонна хвороба

57. Пацієнт віком 56 років довгий час проживає сам у віддаленому гірському районі, по медичну допомогу не звертався. Під час огляду виявлено: настрій підвищений, мислення прискорене, судження поверхневі, стверджує, що багатий, «знайшов у горах скарб» і зараз за ним «прилетить гвинтокрил». Недоречно і грубо жартує, відчуття дистанції відсутнє. Неохайний. Скарг не висловлює. Об'єктивно спостерігається: обличчя асиметричне, девіація язика, анізокорія, реакція зіниць на світло відсутня, дизартрія, нестійкий у позі Ромберга. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ішемічний інсульт
- B. Прогресивний параліч
- C. Біполярний афективний розлад, маніакальний синдром
- D. Шизоафективний розлад, маніакальний синдром
- E. Шизофренія, парафренний синдром

58. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на «порожнечу в душі», «порожнечу в голові», каже: «я ніби не існую, не живу, мені не хочеться жити». Анамнестичні дані викладає плутано, часто на запитання відповідає: «не знаю», «не пам'ятаю». Каже, що відчуває постійний

64. Пацієнтка віком 38 років не висловлює скарг, вважає себе здоровою. Об'єктивно спостерігається: вираз обличчя страдницький, очі сумні, говорить тихо, повільно, висловлює маревні ідеї самоприпинення та самозвинувачення. Із анамнезу відомо, що перестала спілкуватися з родичами, більшу частину часу лежить. Останні 2 тижні говорить про бажання вмерти, просить сина принести отруту або допомогти повіситися. Який стан є показанням для невідкладної шпиталізації пацієнтки?

- A. Відсутність спілкування з родичами
- B. Обсесивно-компульсивний
- C. Депресивний зі стійкими суїцидальними висловлюваннями
- D. Загальмованість
- E. Відмова пацієнта від амбулаторного лікування

65. Пацієнт віком 14 років звернувся по допомогу у супроводі батька у зв'язку із нав'язливим страхом смерті батьків. Зі слів батьків, стан змінився протягом останнього року, коли хлопець почав молитися перед сном, щоб «із батьками нічого не сталося». З часом тривалість молитов збільшилася від кількох хвилин до 4 год, якщо збивався, то починав ритуал з початку, просив маму рахувати його молитви, щоб не збитися. Без цих ритуалів не випускав батьків із квартири, при цьому плакав або дратувався. Який імовірний розлад у дитини?

- A. Біполярний афективний
- B. Посттравматичний стресовий
- C. Генералізований тривожний
- D. Обсесивно-компульсивний
- E. Гіперкінетичний

66. Укажіть специфічний симптом, що характерний для отруєння метиловим спиртом.

- A. Сп'яніння від менших доз алкоголю
- B. Блювання
- C. Тахікардія
- D. Порушення дихання
- E. Порушення зору

67. Пацієнт віком 28 років, спілкуючись із лікарем, безперервно щось говорить у дуже швидкому темпі. З великими труднощами, після кількох повторень вдається його перебити, щоб поставити питання. На запитання починає відповідати, але миттєво відволікається на іншу тему. Зміна теми у розмові пацієнта відбувається практично після кожної фрази. У разі якого розладу спостеріга-

ється таке прискорення асоціативного процесу?

- A. Психогенного психозу
- B. Біполярного афективного розладу
- C. Епілепсії
- D. Шизофренії
- E. Панічного розладу

68. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано до психіатричної лікарні родичами у зв'язку із суїцидальними намірами. Під час бесіди неохоче повідомляє, що два місяці тому після психотравми з'явилася тривога, внутрішній неспокій, порушився сон. Потім з'явилися голоси в голові, які нагадують йому про його гріхи, «влаштовують Армагедон», вказують на його негідність, змушують виконувати їхні вимоги. Стверджує, що «хтось вселився в нього та керує ним». Який психопатологічний синдром спостерігається у пацієнта?

- A. Синдром Кандінського-Клерамбо
- B. Корсаковський синдром
- C. Парафренний синдром
- D. Паранояльний синдром
- E. Синдром Фреголі

69. У молодого чоловіка віком 21 рік через 1 рік після вживання наркотичної речовини розвинувся такий стан: перед очима з'явилися спалахи яскравого світла з неясними контурами трикутників, кіл. Незабаром після цього пацієнт побачив юрбу людей, які загрозливо дивилися в його бік. Спершу виникло почуття екстазу, що змінилося тривогою і занепокоєнням. Кольори і звуки стали насиченими, відчув, що душа відокремлюється від тіла. Цей стан тривав 10 год і завершився депресією. Визначте, яким наркотиком зумовлена описана картина інтоксикації.

- A. Кокаїном
- B. ЛСД
- C. Канабіноїдами
- D. Героїном
- E. Барбітуратами

70. Пацієнтці на фоні резистентності до інших нейролептиків призначили клозапін. Психічний стан покращився, проте згодом у неї з'явилися підвищення температури тіла, запалення ясен, виразки слизової оболонки ротової порожнини, які повільно загоюються. Який побічний ефект від прийому клозапіну спостерігається в пацієнтки?

64. Пацієнтка віком 38 років не висловлює скарг, вважає себе здоровою. Об'єктивно спостерігається: вираз обличчя страдницький, очі сумні, говорить тихо, повільно, висловлює маревні ідеї самоприпинення та самозвинувачення. Із анамнезу відомо, що перестала спілкуватися з родичами, більшу частину часу лежить. Останні 2 тижні говорить про бажання вмерти, просить сина принести отруту або допомогти повіситися. Який стан є показанням для невідкладної госпіталізації пацієнтки?

- A. Відсутність спілкування з родичами
- B. Обсесивно-компульсивний
- C. Депресивний зі стійкими суїцидальними висловлюваннями
- D. Загальмованість
- E. Відмова пацієнта від амбулаторного лікування

65. Пацієнт віком 14 років звернувся по допомогу у супроводі батька у зв'язку із нав'язливим страхом смерті батьків. Зі слів батьків, стан змінився протягом останнього року, коли хлопець почав молитися перед сном, щоб «із батьками нічого не сталося». З часом тривалість молитов збільшилася від кількох хвилин до 4 год, якщо збивався, то починав ритуал з початку, просив маму рахувати його молитви, щоб не збитися. Без цих ритуалів не випускав батьків із квартири, при цьому плакав або дратувався. Який імовірний розлад у дитини?

- A. Біполярний афективний
- B. Посттравматичний стресовий
- C. Генералізований тривожний
- D. Obsесивно-компульсивний
- E. Гіперкінетичний

66. Укажіть специфічний симптом, що характерний для отруєння метиловим спиртом.

- A. Сп'яніння від менших доз алкоголю
- B. Блювання
- C. Тахікардія
- D. Порушення дихання
- E. Порушення зору

67. Пацієнт віком 28 років, спілкуючись із лікарем, безперервно щось говорить у дуже швидкому темпі. З великими труднощами, після кількох повторень вдається його перебити, щоб поставити питання. На запитання починає відповідати, але миттєво відволікається на іншу тему. Зміна теми у розмові пацієнта відбувається практично після кожної фрази. У разі якого розладу спостеріга-

ється таке прискорення асоціативного процесу?

- A. Психогенного психозу
- B. Біполярного афективного розладу
- C. Епілепсії
- D. Шизофренії
- E. Панічного розладу

68. Пацієнта віком 66 років госпіталізовано до психіатричної лікарні родичами у зв'язку із суїцидальними намірами. Під час бесіди неохоче повідомляє, що два місяці тому після психотравми з'явилася тривога, внутрішній неспокій, порушився сон. Потім з'явилися голоси в голові, які нагадують йому про його гріхи, «влаштовують Армагедон», вказують на його негідність, змушують виконувати їхні вимоги. Стверджує, що «хтось вселився в нього та керує ним». Який психопатологічний синдром спостерігається у пацієнта?

- A. Синдром Кандінського-Клерамбо
- B. Корсаковський синдром
- C. Парафренний синдром
- D. Паранояльний синдром
- E. Синдром Фреголі

69. У молодого чоловіка віком 21 рік через 1 рік після вживання наркотичної речовини розвинувся такий стан: перед очима з'явилися спалахи яскравого світла з неясними контурами трикутників, кіл. Незабаром після цього пацієнт побачив юрбу людей, які загрозливо дивилися в його бік. Спершу виникло почуття екстазу, що змінилося тривогою і занепокоєнням. Кольори і звуки стали насиченими, відчув, що душа відокремлюється від тіла. Цей стан тривав 10 год і завершився депресією. Визначте, яким наркотиком зумовлена описана картина інтоксикації.

- A. Кокаїном
- B. ЛСД
- C. Канабіноїдами
- D. Героїном
- E. Барбітуратами

70. Пацієнтці на фоні резистентності до інших нейролептиків призначили клозапін. Психічний стан покращився, проте згодом у неї з'явилися підвищення температури тіла, запалення ясен, виразки слизової оболонки ротової порожнини, які повільно загоюються. Який побічний ефект від прийому клозапіну спостерігається в пацієнтки?

- A. Еозинофілія
- B. Тромбоцитоз
- C. Еритроцитоз
- D. Агранулоцитоз
- E. Дефіцит вітаміну С

71. Пацієнта віком 56 років, далекобійника за професією, шпиталізовано у супроводі родичів. Під час огляду повідомляє, що «три дні як перестав приймати таблетки і стало погано». Об'єктивно спостерігається: пацієнт дисфоричний, тривожний, метушливий, виражений дрібний тремор, підвищення АТ, тахікардія. Під час огляду стався генералізований тоніко-клонічний напад. Оберіть найбільш доцільний метод психотерапії для лікування цієї залежності.

- A. Наративна експозиційна терапія
- B. Раціональна психотерапія
- C. Психоаналіз
- D. 12 кроків
- E. Когнітивно-поведінкова терапія

72. Під час обстрілу в зоні бойових дій у військовослужбовця з'явилися такі симптоми: став тривожним, надмірно метушливим, гіперактивним, не виконував накази командира, неадекватно реагував на людей навколо. Упродовж двох годин стан покращився, симптоми стали менш вираженими, пам'ять на події, що відбувалися, частково втрачена. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гостра реакція на стрес
- B. Контузія
- C. Посттравматичний стресовий розлад
- D. Розлад адаптації
- E. Гострий поліморфний психотичний розлад

73. Пацієнт віком 49 років, прибиральник, кілька тижнів тому проводив дератизацію підвалу, де подряпався. Захворів тиждень тому — став тривожним, тужливим, потім з'явилися спазми дихальних м'язів, судоми, порушення ковтання, елінотеча. Став збудженим, відчував страх. Періодично виникали судомні напади. На момент огляду на мовленнєвий контакт не йде, лежить нерухомо. Реакція зіниць на світло відсутня. Який найімовірніший діагноз?

- A. Епілептичний статус
- B. Ботунізм
- C. Правець
- D. Сказ
- E. Кліщовий енцефаліт

74. ВІЛ-інфікований пацієнт віком 38

років скаржиться на забудькуватість, труднощі у зосередженні уваги, тривале обдумування рішень, важкість у засвоєнні нової інформації. Приймає антиретровірусну терапію. З повсякденними завданнями здатний легко впоратися. Як слід кваліфікувати стан пацієнта?

- A. ВІЛ-асоційована деменція
- B. Великий нейрокогнітивний розлад
- C. Асимптоматичний нейрокогнітивний розлад
- D. Побічна дія антиретровірусних препаратів
- E. Легкий нейрокогнітивний розлад

75. У пацієнта віком 59 років спостерігається прогресуюче погіршення пам'яті, безсоння. Почав помилятися при лічбі, забувати в розмові слова, перестав читати. Одного разу вийшов з дому і заблукав, не міг знайти дорогу додому. Об'єктивно виявлено: тривожний, неспокійний, не може сформулювати думку. Весь час перепитує одне й те саме. У просторі орієнтується погано, плутає дату, день тижня. Не впізнає себе у дзеркалі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Альцгеймера
- B. Дромоманія
- C. Корсаківський амнестичний синдром
- D. Синдром Ганзера
- E. Тривожно-депресивний розлад

76. Пацієнтка віком 17 років вимагає постійного нагляду медичного персоналу через неадекватність поведінки: вона гримасує, голосно сміється, перебиває інших, показує їм язика, говорить неприродним голосом, «сюсюкається», перекидає слова, вигадує свої незвичні поняття, чіпляється до інших пацієнтів, намагається схопити їх за руки і ноги, забирає в них речі, стягує з них ковдру, вилазить на стільці, стіл, ліжко, підвіконня, скаче з відти і голосно регоче, валяється на підлозі і при цьому плескає у долоні, періодично викикує нецензурні слова. Який тип збудження спостерігається в пацієнтки?

- A. Загальне психомоторне
- B. Гебефренічне
- C. Маніакальне
- D. Зумовлене порушенням свідомості
- E. Кататонічне

77. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на біль у грудях. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка пильна та тривожна,

ЧСС — 120/хв, АТ — 140/97 мм рт. ст., широко розширені зіниці. Токсикологічний аналіз позитивний. Який із нижченаведених препаратів, найімовірніше, спричинив таку симптоматику?

- A. Діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД)
- B. Фенциклідин (РСР)
- C. Кокаїн
- D. Героїн
- E. Риталін

78. Пацієнтка віком 19 років, у супроводі матері вперше в житті звернулася до лікаря-несихіатра, амбулаторно, зі скаргами на ненависть до форми свого носу, постійне споглядання себе в дзеркало, нав'язливе порівняння форми свого носу з іншими дівчатами. Появу цих скарг відзначає після закінчення своїх перших відносин. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дисторфофобічний розлад
- B. Депресивний епізод
- C. Біполярний афективний розлад
- D. Межовий розлад особистості
- E. Розлад харчової поведінки

79. Чоловік віком 35 років чує «голос» усередині голови, схожий на голос робота, який коментує усе, що відбувається навколо. За словами пацієнта, чує його вже 8-9 років. Спочатку здавалося, що це голос справжньої людини, проте згодом він змінився. Укажіть психопатологічний феномен у цього пацієнта.

- A. Псевдогалюцинація
- B. Афективна ілюзія
- C. Функціональна галюцинація
- D. Істинна галюцинація
- E. Парейдолія

80. Пацієнтка віком 35 років звернулася до лікаря з проханням виписати рецепт на діазепам. Розповідає, що 2 місяці тому після сварки із сестрою виникло відчуття «віднімання кінцівок», стала неспроможною самостійно стояти і ходити. Усі ці симптоми регресували після прийому діазепаму. З того часу приймала препарат по 1 таблетці 3 рази на день, упродовж останніх 2-х тижнів — по 2 таблетки 3 рази на день. Тепер вважає таке дозування недостатнім. Висловлює скарги на тривожу, оніміння кінцівок, пітливість, відсутність апетиту, безсоння, які виникли після припинення вживання препарату. Який найімовірніший діагноз?

- A. Маскована депресія
- B. Залежність від стимуляторів
- C. Істеричний невроз
- D. Епілесія
- E. Залежність від транквілізаторів

81. Укажіть емоційний прояв, який не є типовим для циркулярної депресії.

- A. Печаль
- B. Тривога
- C. Туга
- D. Відчай
- E. Безнадійність

82. У пацієнта віком 42 роки раптово виникло психомоторне збудження. В анамнезі: 19 років хворіє на епілепсію. У психічному статусі: до продуктивного мовленнєвого контакту не доступний, дезорієнтований у місці, часі та власній особистості, поведінкою виявляє зорові та слухові галюцинації загрозливого змісту, відривчасто висловлює маячні ідеї стосунку і переслідування. На обличчі вираз страху і гніву, агресивний, руйнує все навколо. Вкажіть психопатологічний синдром, що виник у пацієнта.

- A. Деліріозний
- B. Параноїдний
- C. Гібефренічний
- D. Сутінковий
- E. Маніакальний

83. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 8-ми місяців відмовлялася виходити з дому, вважаючи, що сусіди намагаються її нашкодити. Вона боїться, що якщо вони побачать її, то завдадуть болю, і знаходить багато дрібних доказів на підтримку цього, а саме: сусіди залишали свої сміттєві баки на вулиці, щоб вона перечебилася, паркували свої машини біля своїх під'їздів, щоб могли сховатися за ними та шпигувати за нею, і проходили повз її будинок, щоб спробувати зазірнути, де вона ховається. Пацієнтка стверджує, що настрій у неї хороший і було б «краще, якби вони залишили її в спокої». Заперечує, що чула, як сусіди чи хтось інший з нею розмовляють, але впевнена, що вони планують «спричинити їй смерть і каліцтво». Який найімовірніший діагноз?

- А. Посттравматичний стресовий розлад
- В. Шизоафективний розлад
- С. Велика депресія з психотичними ознаками
- Д. Маячний розлад
- Е. Шизофренія

84. Пацієнтка віком 15 років уперше доставлена до психіатричного стаціонару у зв'язку із суїцидальною спробою в супроводі батьків. За словами батьків, після нещасливого кохання стала подаленою, висловлювала думку, що не варта життя. Під час огляду виявлено: мовчазна, напружена, на запитання відповідає вкрай формально. Суїцидальну спробу заперечує, відмовляється від інгібілізації, наполягає, щоб її відпустили додому. Яку форму первинної облікової документації потрібно оформити першочергово?

- А. Згоду батьків на інгібілізацію
- В. Згоду особи на інгібілізацію
- С. Згоду особи на лікування
- Д. Згоду особи на проведення психіатричного огляду
- Е. Згоду батьків на проведення психіатричного огляду

85. Пацієнт віком 66 років переказує сюжет відомої книжки іншим і стверджує, що ці події відбувалися з ним самим. Крім цього, у пацієнта спостерігається сплутаність думок, труднощі з концентрацією уваги, емоційні коливання, дратівливість. Яке порушення пам'яті спостерігається у пацієнта?

- А. Криптомнезія
- В. Конфабуляція
- С. Апрозексія
- Д. Псевдоремінісценція
- Е. Анекфорія

86. Пацієнт віком 68 років скаржиться на зниження пам'яті, складність запам'ятовування нової інформації, наприклад, не може згадати зміст статті, яку прочитав нещодавно, труднощі під час виконання повсякденних справ через забудькуватість, розгубленість. Під час опитування виявлено: труднощі з формулюванням фраз, добором потрібних слів. Об'єктивно спостерігається: періодичне роздратування, відсторонення, замовкання. Зі слів дружини, стан погіршувався поступово протягом 2-х років, останнім часом іноді дезорієнтується на місці, не може зрозуміти, де він знаходиться. За результатами МРТ головного мозку виявлено: озна-

ки атрофії медіальної скроневі частки. Який найімовірніший діагноз?

- А. Епілепсія
- В. Деменція з тільціями Леві
- С. Хвороба Альцгеймера
- Д. Хвороба Паркінсона
- Е. Хвороба Гентінгтона

87. Дівчинка з легкою формою ДЦП у присутності матері, яка весь час робить їй зауваження, розгублюється, замовкає, не знає, як себе поводити. Які риси характеру можуть виникнути в дітей із дитячим церебральним паралічем у разі виховання в умовах надмірного навантаження та вимогливості?

- А. Впевненість
- В. Почуття власної гідності
- С. Рішучість
- Д. Переоцінка своїх можливостей
- Е. Безпорадність

88. Пацієнт наркологічного стаціонару віком 52 роки звинувачує дружину у постійних зрадах. За її словами, це триває давно, з роками погіршилося, останнім часом стверджує, що дружина зраджує йому все життя і доньку народила також від коханця. Встановив удома камери, щоб перевіряти, хто ходить до них додому. Кілька разів кидався з кулаками на інших чоловіків, яких запідозрив у стосунках із його дружиною. Укажіть синдром, який, найімовірніше, спостерігається у пацієнта.

- А. Делірій
- В. Маячний
- С. Психоорганічний
- Д. Галюциноз
- Е. Корсаковський

89. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на страшні картини в голові. Наприклад, яскраво бачить, що матір і батька вбиває злочинець, зайшовши через двері, які вона залишила відчиненими. Хвилюється, що через її необачність може померти близька людина. Надзвичайно переживає через порядок у речах. Патологічно зосереджена на тому, щоб речі лежали на своїх місцях, витрачає на це багато часу. Як називаються думки та образи, що виникають у пацієнтки?

- А. Марення
- В. Галюцинації
- С. Обсесії
- Д. Псевдогалюцинації
- Е. Ілюзії

90. Чоловікові, який намагався накласти на себе руки, стрибнувши з даху, завадили працівники поліції та медики. Був доставлений до психіатричного закладу, проте від госпіталізації відмовляється. Яка стаття Закону України «Про психіатричну допомогу» визначає підстави для примусової госпіталізації до психіатричного закладу і чи слід її застосувати в цьому разі?

- А. Стаття 18, так
- В. Стаття 14, ні
- С. Стаття 3, так
- Д. Стаття 18, ні
- Е. Стаття 14, так

91. Під час огляду пацієнта віком 28 років спостерігається: ейфорія, неспокій, гіперактивність, легко відволікається, постійно та швидко говорить, не встигає завершити одну думку, як «перестрибує» на іншу, роздає всім навколо поради. Також пацієнт каже, що він найбагатший та найталановитіший чоловік у світі і має вплив на всі уряди світу. Рідні повідомили, що він останні дні взагалі не спав, витрачав купу грошей на непотріб, узяв велику суму в кредит. Яке лікування необхідно призначити пацієнту?

- А. Сертралін
- В. Оланзапін + вальпроєва кислота
- С. Ламотриджин
- Д. Оланзапін + флуоксетин
- Е. Карбамазепін

92. Жінку віком 54 роки у супроводі родичів госпіталізовано до психіатричного стаціонару. Скарги самотійно не висловлює. На звернене мовлення реагує вибірково, на питання відповідає не завжди по суті, до продуктивного контакту малодоступна. Вираз обличчя беземоційний, занурена у світ власних переживань. Зі слів родичів, хворіє на резистентну форму психозу вже 15 років. Потягом останніх 5-ти років повністю відмовилася від соціальних контактів, перестала цікавитися будь-чим, залежується в ліжку, не дотримується правил особистої гігієни, перестала виходити з дому. Визначте тип сформованого дефекту особистості.

- А. Паранояльний
- В. Гіпоманіакальний
- С. Психопатоподібний
- Д. Анато-абулічний
- Е. Астенічний

93. Одинадцятирічна дівчинка тимчасово проживає у чужій країні у статусі біженки. Скаржиться на поганий настрій, плаксивість, небажання ходити до школи та навчатися там чужою мовою. Сумує за рідним містом та друзями. Розповідає, що періодично в уяві спонтанно виникають картини знайомих місць. Хвилюється, що їй ніколи не вдасться повернутися додому. Іноді спостерігаються нічні пробудження. Укажіть імовірний діагноз.

- А. Пубертатний криз
- В. Розлад адаптації
- С. Посттравматичний стресовий розлад
- Д. Генералізований тривожний розлад
- Е. Депресивний епізод

94. Мати хлопчика віком 14 років звернулася до лікаря-психіатра зі скаргами на те, що її син змінився — став конфліктним, нестриманим, агресивним. Часто бреше, почав красти з дому гроші та пізно приходить додому. Про нових друзів нічого не розповідає. Вчителі зі школи повідомляють про часті пропуски ним занять і зниження успішності. Який найімовірніший діагноз?

- А. Розумова відсталість
- В. Розлад емоцій та поведінки
- С. Розлад дефіциту уваги та гіперактивність
- Д. Афективні розлади у дітей та підлітків
- Е. Адиктивна поведінка у дітей та підлітків

95. У пацієнта віком 38 років спостерігається швидка зміна симптоматики у вигляді афективних коливань: від підвищеного до зниженого настрою. Симптоматика триває близько 2-х тижнів. Два і чотири роки тому у пацієнта спостерігалася депресивна симптоматика тривалістю 3 і 5 місяців. Який найімовірніший діагноз?

- A. Рекурентний депресивний розлад
- B. Депресивний епізод помірного ступеня
- C. Біполярний афективний розлад, депресивний епізод
- D. Маніакальний епізод
- E. Біполярний афективний розлад, змішаний епізод

96. До лікаря-психіатра звернувся комісований військовослужбовець, який 6 місяців тому повернувся із зони бойових дій. Скаржиться на головний біль, порушення сну, кошмарні сновидіння зі змістом психотравмуючих подій, панічні атаки, дратівливість, напливи спогадів про психотравмуючі події, погіршення пам'яті, відчуження від близьких людей. За словами пацієнта, він неодноразово був свідком втрати бойового складу на полі бою, складно переживає загибель своїх побратимів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гостра реакція на стрес
- B. Змішаний тривожно-депресивний розлад
- C. Панічний розлад
- D. Генералізований тривожний розлад
- E. Посттравматичний стресовий розлад

97. Під час огляду пацієнтки віком 67 років спостерігається: охайно одягнута та зачесана, на привітання уєміхається, у відповідь на різні питання не відповідає зовсім. Інструкції не виконує. Зі слів чоловіка відомо, що проблеми з пам'яттю почалися близько 7-ми років тому. Спочатку вона забувала, що робила нещодавно, потім перестала розрізняти родичів, вважала, що їй 35 років. Раніше часто залишала включеною плити та воду. Одного разу вийшла самотійно з дому та загубилася. Потребує постійного догляду через втрату навиків самообслуговування. Який найімовірніший діагноз?

- A. Помірні (когнітивні) порушення пізнавальної функції органічного генезу
- B. Деменція при хворобі Альцгеймера
- C. Деменція при хворобі Гентінгтона
- D. Делірій, заподіяний деменцією
- E. Деменція при хворобі Піка

98. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на напади прищвидшеного серцебиття, підвищення АТ, задишки, запаморочення, страху знепритомніти, страху залишатися наодинці, тремор тіла. У анамнезу відомо, що такі стани спершу виникали раз на декілька днів, а

тепер трапляються щодня, тривають до 30 хв і минають самотійно. Результати додаткових обстежень у нормі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Панічний розлад
- B. Фобічний розлад
- C. Соматоформний розлад
- D. Посттравматичний стресовий розлад
- E. Емоційно-нестабільний розлад особистості

99. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на відчуття грудки в горлі, перепади настрою, плаксивість, затерпання рук, короточасні стани втрати свідомості, порушення сну, апетиту, зниження настрою. Об'єктивно спостерігається: егоцентрична, демонстративна, говорить гучним голосом, активно жестикулює та звинувачує у всіх проблемах свого чоловіка. Вороже налаштування проти нього, грає роль жертви, вимагає до себе особливого ставлення та співчуття. Укажіть розлад особистості, що розвинувся у пацієнтки.

- A. Низоїдний
- B. Параноїдний
- C. Ананкастний
- D. Гістеріонний
- E. Астенічний

100. Який із нижченаведених лікарських засобів є блокатором опіатних рецепторів?

- A. Апоморфін
- B. Бупренорфін
- C. Амфетамін
- D. Налоксон
- E. Морфін

101. До лікаря-психіатра звернувся чоловік віком 37 років у супроводі дружини. За її словами, чоловік вночі не спав, періодично до чогось прислухався, озирався, був впевнений, що чує крізь стіну голоси, які говорять про нього, погрожують та готуються знищити його. Намагався повіситися. Зловживає спиртними напоями більше 15 років, останній прийом — 2 доби тому. Об'єктивно спостерігається: орієнтований у собі правильно, зовні тривожний, вираз обличчя наляканий, збуджений, на місці не утримується, намагається тікати. Критично свій стан не оцінює. Вкажіть провідний психопатологічний синдром, що виник у пацієнта.

- A. Гебефренічний
- B. Деліріозний
- C. Аментивний
- D. Параноїдний
- E. Сутінковий

102. Пацієнтка віком 21 рік висловлює скарги на порушення пам'яті: «винадають проміжки часу». У бесіді повідомляє, що «всередині мене живе четверо: Поліна, Аліна, Марина та ще одна». Стверджує, що «Аліна робить за мене погані речі». Стан змінився після конфлікту з батьками. Який найімовірніший діагноз?

- A. Шизофренія
- B. Множинний розлад особистості
- C. Транс
- D. Синдром дереалізації-деперсоналізації
- E. Дисоціативна амнезія

103. Пацієнт віком 27 років із шизофренією скаржиться, що періодично відчуває «голоси» представників інопланетної цивілізації, що керують його думками та рухами за допомогою невідомих науці променів, примушуючи скоїти самогубство. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Синдром психічного автоматизму
- B. Амбулаторний автоматизм
- C. Ажитована депресія
- D. Деліріозний стан
- E. Маніакальне збудження

104. У пацієнта віком 52 роки підгостро розвинулися психотичні симптоми, поліморфний судомонодібний синдром із превалюванням міоклоній у кистях рук, рухові порушення у вигляді акінезії та ригідності з «лобовим» застиганням та збільшеним латентним періодом відповіді, а також виразні когнітивні порушення рівня глибокої деменції. Який висновок можна зробити, беручи до уваги анамнез розвитку, а також зловживання алкоголем протягом останніх 12-ти років та недостатність харчування?

- A. Алкогольний делірій
- B. Алкогольно-токсична енцефалопатія Гайе-Верніке
- C. Корсаківський (амнестичний) синдром
- D. Судомні напади внаслідок алкоголізму
- E. Тотальна деменція

105. П'ятирічного хлопчика привели до

лікаря-психіатра через те, що він не уважний у школі, метушиться, не хоче сидіти в класі, удома надмірно балакучий, і йому складно чекати своєї черги. Мовлення і моторика відповідають віку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Первазивне порушення розвитку
- B. Розлад дефіциту уваги з гіперактивністю
- C. Опозиційний зухвалий розлад
- D. Тривожний розлад розлуки
- E. Легка розумова відсталість

106. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на непосидючість, слинотечу. До психіатричної лікарні шпиталізований через загострення параноїдної шизофренії. Під час шпиталізації спостерігалось значне психомоторне збудження, для лікування якого пацієнт отримав 15 мг галоперидолу на добу. Під час огляду виявлено: непосидючий, тупотить ногами, виражені мимовільні м'язові скорочення в руках, ногах, а також у ділянці язика та шиї. Укажіть препарат для лікування стану, що виник у пацієнта.

- A. Буспірон
- B. Амантадин
- C. Сульфат магнію
- D. Галоперидол
- E. Дифенгідрамін

107. До лікаря звернувся чоловік віком 63 роки з ознаками психічної залежності, а саме: нестерпним бажанням закурити, напруженістю, підвищеною дратівливістю з незначного приводу, в'ялістю, апатією, пригніченим настроєм, незадоволеністю всім, підвищеною сонливістю, інколи дизсомнією. Курить протягом 45 років по 2 пачки на добу. Скаржиться на зниження уваги, помилки під час виконання роботи, яка потребує уваги, зниження слуху, виникнення значних розладів внутрішніх органів — серця, шлунка, печінки, кишечника. Вживання якої психоактивної речовини спричинило ці розлади?

- A. Нікотину
- B. Опіоїдів
- C. Психостимуляторів
- D. Алкоголю
- E. Психоделічних засобів

108. Чоловік віком 67 років відзначає, що протягом останніх 2-3-х тижнів помітив зміни у своєму психічному стані: ввечері відчуває запах «горілих дров», часом вночі «бачить прозорих людей». Під час цього відчуває страх. Усвідом-

лення власного стану не порушене, шукає пояснень своєму психічному стану. Укажіть провідний синдром, що виник у пацієнта.

- ☒ А. Нав'язливих страхів
- ☐ В. Тривожний
- ☐ С. Галюцинаторний
- ☐ D. Галюцинаторно-параноїдний
- ☐ Е. Деліріозний

109. Пацієнт віком 39 років, одружений, втративши роботу, перейшов від щоденних ін'єкцій наркотику до випадкових. Через кілька тижнів став тривожним, напруженим, говорив дружині, що чує, як торговці наркотиками і поліція розмовляють про нього на вулиці. Став барикадуватися вдома, перестав їсти, оскільки побоювався отруєння. Під час огляду замкнений, на запитання відповідає коротко. Настрій байдужий, повідомляє про переслідування бандою наркоторговців. Свідомість не порушена. Яке найбільш доцільне лікування в цьому разі?

- ☐ А. Амітриптилін
- ☐ В. Фенібут
- ☒ С. Галоперидол
- ☐ D. Діазепам
- ☐ Е. Карбамазепін

110. Пацієнт віком 14 років скаржиться на нічні страхи та ходіння уві сні протягом 2-х років. В анамнезі: у віці 3 і 7 років по одному фебрильному судомному стану під час інфекційного захворювання. Сомнамбулізм відзначався досить часто. Забіякуватий, жорстокий. З'явилися дисфорії. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Фобії
- ☐ В. Бруксизм
- ☐ С. Нічний енурез
- ☒ D. Епілептичні нічні пароксизми
- ☐ Е. Дромоманія

111. До лікаря-психіатра звернулася матір із хлопчиком віком 14 років зі скаргами на почасти́пання абсансних нападів, зміну поведінки і рис характеру дитини. Хлопчик став дратівливим, запальним, злісним, прискіпливим, егоцентричним. Разом із цим, може бути занадто ввічливим, улесливим, педантичним. Призначте медикаментозне лікування.

- ☒ А. Вальпроєва кислота
- ☐ В. Карбамазепін
- ☐ С. Діазепам
- ☐ D. Галоперидол
- ☐ Е. Фенобарбітал

112. Пацієнтка віком 24 роки починає психотерапію, стверджуючи, що вона водночас у відчаї та нудзі, протягом останніх 5-ти або 6-ти років відчувала періодичну тривогу, депресію та зробила кілька суїцидальних жестів. Повідомляє про різні імпульсивні випадки та поведінку, що призводить до пошкоджень, а також сексуальну розбещеність. Задається питанням, чи може бути лесбійкою, хоча більшість її сексуального досвіду була з чоловіками. Раптово припинила дві попередні спроби психотерапії, тому що злилася на лікаря, оскільки той не хотів призначати анксиолітики. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Гістрійонний розлад особистості
- ☐ В. Емоційно нестабільний розлад особистості
- ☒ С. Дистимія
- ☐ D. Розлад контролю над імпульсами, не уточнений іншим чином
- ☐ Е. Антисоціальний розлад особистості

113. Пацієнтка віком 32 роки із 22-річного віку хворіє на параноїдну шизофренію. Під час перебування на стаціонарному лікуванні з приводу загострення хвороби стан пацієнтки раптово погіршився: підвищилися температура тіла до 39,5°C, АТ — 160/100 мм рт. ст., обличчя гіперемоване, масне, губи сухі, вкриті кірочками, біло-коричневий наліт на язичку. На зовнішні подразники майже не реагує, перебуває у ліжку. Яка лікувальна тактика в цьому разі?

- ☐ А. Клопиксол-депо
- ☐ В. Галоперидол
- ☐ С. Люмбальна пункція
- ☒ D. Електросудомна терапія
- ☐ Е. Жарознижувальні препарати

114. Семирічному хлопчику діагностовано розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та рекомендовано медикаментозну терапію. Який препарат можна призначити дитині?

- ☐ А. Рисперидон
- ☐ В. Прегабалін
- ☐ С. Флуфеназин
- ☒ D. Метилфенідат
- ☐ Е. Гідроксизин

115. Під час огляду трирічної дитини виявлено: відсутність експресивного мовлення, нерозуміння зверненого мовлення, відсутність вказівного жесту. Зі слів батьків, у дитини спостерігається відсутність зацікавленості та гри з іншими дітьми, повторювані махання руками та виражена вибірковість у харчуванні. Який імовірний розлад у дитини?

- A. Розлад відсутній, вікова норма
- B. Посттравматичний стресовий розлад
- C. Нервова анорексія
- D. Дитячий аутизм
- E. Гіперкінетичний розлад

116. Шестирічну дівчинку мама привела до лікаря зі скаргами на те, що дитина відстає в навчанні, неуважна, трапляються періодичні істерики на уроках та вдома. Зазначає, що дівчинка не розмовляла до 4-х років. У школі дружелюбна, але не може виконати більшість завдань, навіть якщо їй допомагають. Яка з нижченаведених діагностичних процедур буде найбільш корисною для встановлення діагнозу?

- A. Перевірка слуху
- B. Тестування IQ
- C. Загальний аналіз крові
- D. Електроенцефалограма
- E. Люмбальна пункція

117. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на поганий сон, часте тремтіння, запаморочення, нудоту, пітливість, напруження м'язів шиї та спини. Також відзначає неможливість зосередитися, розгубленість, постійне занепокоєння. За словами пацієнтки, вона впадає в паніку через те, що може статися щось погане. Який найімовірніший діагноз?

- A. Панічний розлад
- B. Генералізований тривожний розлад
- C. Клімактеричний синдром
- D. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- E. Агорафобія з панічним розладом

118. Пацієнтці віком 28 років вперше діагностовано тяжку депресію. Призначено групову когнітивно-поведінкову терапію та лікування антидепресантом із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Через 4 тижні після початку лікування покращення психічного стану не спостерігається. Що першочергово має зробити лікар згідно з рекомендаціями NICE?

A. Збільшити дози відповідно до інструкції для медичного застосування препарату, за умови відсутності суттєвих побічних ефектів

B. Призначити інший антидепресант, якщо присутні побічні ефекти

C. Розглянути можливість поєднання антидепресанту з іншим антидепресантом

D. Призначити інший антидепресант за бажанням пацієнтки

E. Переконатися, що пацієнтка приймає препарат регулярно та відповідно до призначеної дози

119. Пацієнтка віком 72 роки повідомляє, що її чоловік останнім часом зраджує їй. Незважаючи на те, що він інвалід із серцевою недостатністю і зовсім не виходить із дому, він нібито «приймає у себе жінку», коли пацієнтка виходить до магазину. Знайшла у себе «чужі жіночі речі». Надалі з'ясувалося, що це її речі, які вона вже давно не носить. На спроби її переконати дратується й ображається. Який розлад спостерігається у пацієнтки?

A. Органічний афективний розлад

B. Органічний маячний розлад

C. Деменція при хворобі Альцгеймера

D. Депресивний епізод із психотичними симптомами

E. Параноїдна шизофренія

120. Пацієнтку віком 23 роки шпиталізовано з депресією, тривогою, маячними ідеями самоприпинення, самозвинувачення. Вночі не спала, раптово почала голосити, розірвала одяг, вириває волосся, б'ється головою об стіну, заламує руки, просить зробити їй укол, щоб померти. Укажіть тип депресії.

A. Анестетична

B. Ажитована

C. Адинамічна

D. Астенічна

E. Гнівлива

121. Пацієнт віком 38 років, доступний до малопродуктивного контакту, орієнтований у власній особі, місці, плутає день і число. Відомо, що довгий час зловживав алкоголем, спостерігаються запої. Судження поверхневі, погано розуміє та сприймає нову інформацію, пам'ять знижена. Скаржиться на «двоїння» в очах. Об'єктивно спостерігається: птоз, ністагм, не може встояти у позі Ромберга. На МРТ виявлено пошкодження в таламусі з розширеними шлуночками та втратою щільності в

мамілярних тілах, симетричні ураження середнього мозку і мозочка. Яке додаткове дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- A. Аналіз вмісту шлунка на ботулотоксин
- B. Аналіз алкоголю, який вживав пацієнт, на вміст метанолу
- C. ІФА крові на антитіла до борелій
- D. Серологічне дослідження на сифіліс
- E. Аналіз крові на вміст вітаміну B₁

122. Пацієнт віком 16 років направлений на експертизу з військомату. З дитинства відставав у розумовому розвитку від однолітків, травми голови, нейроінфекції в дитинстві заперечує. Навчався в школі, з класу в клас переводився формально. Закінчив 9 класів школи. У подальшому навчання не продовжував, допомагав батькам із господарством. Зі слів батьків легко піддається впливу інших. Об'єктивно спостерігається: на запитання відповідає по суті, вміє читати, писати, виконувати елементарні математичні дії. Не може пояснити значення прислів'їв та приказок, мислення конкретно-образне. Під час психологічного дослідження виявлено, що IQ — 68 балів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності
- B. Органічний розлад особистості
- C. Розумова відсталість помірна
- D. Дитячий аутизм
- E. Розумова відсталість легкого ступеня

123. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, отриманого під час весілля доньки. На третій день пацієнт став агресивним, збудженим, тривожним. Наполягав на виписці, вважав, що він на м'ясокомбінаті і з нього хочуть зробити ковбасу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, АТ — 160/90 мм рт. ст., ЧСС — 110/хв. Із анамнезу відомо, що періодично має псевдозапої. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Стан відміни алкоголю з делірієм
- B. Стан відміни опіатів з делірієм
- C. Алкогольний галюциноз
- D. Транзиторна ішемічна атака
- E. Стан відміни алкоголю без делірію

124. У пацієнта віком 32 роки у стані абстиненції послідовно виникли такі симптоми: погіршення настрою, дратівли-

вість, озноб, тремор, мідріаз, нежить, біль у суглобах, блювання, пронос, тонічні судоми. Для якого виду залежності характерна ця картина абстиненції?

- A. Кокаїнової
- B. Барбітуратової
- C. Ефедренової
- D. Опійної
- E. Канабіноїдної

125. Дев'ятирічний хлопчик направлений до психіатра через низьку успішність та неслухняність у школі. Результати оцінки інтелекту не виявили порушень, IQ знаходиться в межах норми. Учитель повідомляє, що порівняно з іншими в класі, хлопцю важко утримувати увагу, він дуже непосидючий та метушливий, постійно нудиться та відволікає інших під час занять. Футбольний тренер хлопця та вчитель музики також вказують на його непосидючість та неухважність, які заважають навчанню та тренуванням. Який імовірний розлад у дитини?

- A. Специфічні порушення розвитку шкільних навичок
- B. Розлад відсутній, вікова норма
- C. Генералізований тривожний розлад
- D. Дитячий аутизм
- E. Гіперкінетичний розлад

126. Пацієнтку віком 24 роки шпиталізовано у стані психомоторного збудження. Об'єктивно спостерігається: стогне, кричить, виє, риде, заламує руки, висловлює ідеї провини, втрати сенсу життя, відчуває тривогу, тугу та відчай з відчуттям тяжкості за грудниною. Ризик виникнення якого невідкладного стану може бути у пацієнтки?

- A. Патологічного афекту
- B. Суїцидальної спроби
- C. Дисфорії
- D. Істеричного нападу
- E. Аменції

127. Пацієнт віком 27 років скаржиться на головний біль, біль у суглобах, слабкість, катаральні явища, підвищення температури тіла до 39°C. Встановлено попередній діагноз: грип. На 3-й день захворювання на тлі високої температури тіла виникло глибоке затьмарення свідомості, порушення орієнтування в місцезнаходженні, часі, власній особистості, мислення і мовлення сплутані, пацієнт безладно борсається в ліжку, здригається, прагне підвестися. Ви-

кликано машину екстреної (швидкої) медичної допомоги. До якого відділення необхідно шпиталізувати пацієнта в цьому разі?

- A. Неврологічного
- B. Терапевтичного
- C. Психіатричного стаціонару
- D. Реанімаційного
- E. Інфекційного стаціонару

128. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на снинотечу, порушення ковтання, м'язові спазми, порушення сну та гарячку. Нещодавно була збільшена доза антипсихотичного препарату для лікування шизофренії. За результатами лабораторних досліджень виявлено: підвищення рівня креатинфосфокінази та лейкоцитоз. На момент обстеження пацієнтка знаходилася в стані збудження та зміненої свідомості. Який стан виник у пацієнтки?

- A. Летальна кататонія
- B. Злоякісний нейролептичний синдром
- C. Злоякісна гіпертермія
- D. Серотоніновий синдром
- E. Центральний антихолінергічний синдром

129. Який стан розладу психіки та поведінки виникає в пацієнтів які вживають кокаїн?

- A. Коагулопатія
- B. Підвищена розумова активність
- C. Збільшення апетиту
- D. Покращення сну
- E. Параноя

130. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 33 роки працював в іншій країні кухарем, проживав у досить складних умовах. Став помічати плутанину в думках, відчуття недоброзичливості та осуду з боку колег та оточення, зрозумів, що хтось впливає на його думки та хоче заподіяти йому шкоду. Насилу дістався додому, їхав кілька діб, тому що «доводилося міняти транспорт через стеження». Після повернення залишався підозрілим, не виходив із квартири кілька діб. Звернувся по допомогу на вимогу сестри. Відомо, що родич по материнській лінії покінчив життя самогубством у молодому віці. Який психічний розлад спостерігається у пацієнта?

- A. Шизоафективний розлад
- B. Параноїдна шизофренія
- C. Кататонічна шизофренія
- D. Шизотиповий розлад
- E. Органічний маячний розлад

131. У пацієнтки віком 25 років діагностований БАР, поточний епізод помірної депресії. Який стабілізатор настрою є рекомендованим при лікуванні цього епізоду та з метою запобігання подальших загострень?

- A. Ламотриджин
- B. Топірамат
- C. Вальпроат натрію
- D. Прегабалін
- E. Карбамазепін

132. У пацієнта з депресивним розладом на фоні прийому двох серотонінергічних антидепресантів змінився психічний стан — настрої підвищений, непосидючий, гіперзбудливий, порушилася координація рухів, спостерігається тремор, озноб, порушення координації, гіперрефлексія, діарея. Заподозрено серотоніновий синдром. Який лікарський засіб ефективний при лікуванні цього стану?

- A. Сукцинілхолін
- B. Бромокриптин
- C. Доразенам
- D. Парацетамол
- E. Дантролен

133. До лікаря-психіатра звернулася мати з семирічним сином, який не слухає вчителя та не дотримується правил на уроках, може гучно розмовляти, встати з-за парти, щоб піти гратися під час занять, відволікає увагу інших дітей, має труднощі в навчанні, б'є інших дітей. Характерний конкретний рівень мислення, ускладнення з абстрагуванням, обмеженість словникового запасу, відсутні знання та вміння, які є у дітей його віку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Недагогічна занедбаність
- B. Розумова відсталість
- C. Дефіцит уваги
- D. Розлад емоцій та поведінки
- E. Аутизм

134. Пацієнт віком 35 років скаржиться на те, що не може контролювати кількість вжитої їжі. На фоні хронічного стресу почав безконтрольно їсти ввечері. Припиняє прийом їжі тоді, коли шлунок наповниться до відчуття нудоти. Який патологічний стан спостеріга-

ється у пацієнта?

- A. Булімія
- B. Орторексія
- C. Анорексія
- D. Розлад адаптації, пов'язаний зі стресом
- E. Компульсивне переїдання

135. Пацієнт віком 38 років скаржиться на безсоння, зниження настрою, дратівливість. Об'єктивно спостерігається: підозрілий, недовірливий, агресивний, схильний до конфліктів із будь-якого приводу. З дитинства не має друзів, дружину підозрює у зраді. Укажіть розлад особистості, що спостерігається в пацієнта.

- A. Істеричний
- B. Параноїдний
- C. Шизоїдний
- D. Ананкастний
- E. Астенічний

136. Пацієнтка віком 25 років, раніше вже зверталася до психіатра з приводу епізодів біполярного афективного розладу. Відзначає нинішнє погіршення стану протягом останніх 6-ти місяців після того, як самостійно припинила приймати підтримуючу терапію. Об'єктивно спостерігається: загальмована, мовлення сповільнене, на питання відповідає після пауз, вираз обличчя страдницький, зовнішній вигляд неохайний. Скаржиться на слабкість, втому, дуже поганий настрій, відсутність мотивації, відсутність апетиту та схуднення на 6 кг протягом останніх 2-х місяців, суїцидальні думки. Повідомляє, що відчуває себе винною у всіх гріхах людських, а також чує незнайомі голоси в середині голови, які кажуть, що через неї у світі йдуть війни. Який епізод біполярного афективного розладу спостерігається в пацієнтки?

- A. Помірна депресія
- B. Маніакальний із психотичними симптомами
- C. Змішаний
- D. Тяжка депресія з психотичними симптомами
- E. Тяжка депресія без психотичних симптомів

137. У пацієнтки віком 32 роки впродовж останніх 3-х тижнів виникли та наростали відчуття відкритості та «чужості» думок, відчуття керування та впливу, ідеї відношення та впливу, голоси коментуючого характеру, зі зни-

женим настроєм, страхом та тривогою. Кілька років тому у пацієнтки спостерігався період підвищеного настрою, висловлювала надмірні ідеї власних можливостей, мала неадекватно багато планів, бралася за кілька справ одночасно, мало спала. По медичну допомогу не зверталася. Для якого розладу характерна така симптоматика?

- A. Обсесивно-компульсивного розладу
- B. Гострого поліморфного психотичного розладу із симптомами шизофренії
- C. Маніакального епізоду
- D. Депресивного епізоду
- E. Шизоафективного розладу

138. До лікаря-психіатра звернулася матір із семирічною дитиною зі скаргами на порушення здатності дитини регулювати та контролювати свою поведінку, зниження уваги, імпульсивність. Який найімовірніший діагноз?

- A. Адекватна поведінка у дітей та підлітків
- B. Розлади мовлення у дітей та підлітків
- C. Афективні розлади у дітей та підлітків
- D. Органічні розлади у дітей та підлітків
- E. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності

139. Під час огляду пацієнтки віком 25 років спостерігається: знерухомлена, вираз обличчя мінливий, відображає страх, здивування або захоплення, на запитання лікаря не реагує. Через кілька днів пацієнтка пішла на контакт та розповіла, що спостерігала, як «янгולי спустилися на променях світла та вступили у боротьбу з демонами». Не пам'ятає, коли і як вона опинилася в лікарні. Який психопатологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Конфабуляція
- B. Делірій
- C. Псевдоремінісценція
- D. Аменція
- E. Онейроїд

140. До приймального відділення родичі привезли пацієнта віком 56 років, далекобійника за професією. Пацієнт повідомляє, що «три дні тому перестав приймати таблетки і стало погано». Об'єктивно спостерігається: дисфоричний, тривожний, метушливий, виражений дрібний тремор, підвищення АТ, тахікардія. Під час огляду стався генералізований тоніко-клонічний напад. Які психоактивні речовини, найімовірніше,

вживав пацієнт?

- A. Психостимулятори
- B. Трамадол
- C. Барбітурати
- D. Амфетаміни
- E. Транквілізатори

141. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано після того, як він був надзвичайно стурбований у своїй кімнаті гуртожитку, оскільки був упевнений, що адміністрація університету надсилає «ударний загін», щоб убити його. Зазначає, що бачить «видіння» чоловіків, одягнених у чорне, які мають зброю та переслідують його. Процес мислення пацієнта є відносно непорушеним, без блокування думки чи вільних асоціацій. Які препарати, найімовірніше, спричинили ці симптоми?

- A. Героїн
- B. Амфетаміни
- C. MDMA (екстазі)
- D. Барбітурати
- E. Бензодіазепіни

142. Пацієнт віком 38 років упродовж року брав участь у бойових діях. Після повернення додому вночі спить погано, зривається, кричить. Було кілька епізодів, коли при голосних звуках падав на землю та прикривав голову руками. За словами дружини, періодично змінюється на обличчі, стає неспокійним. Подразливий, легко афектує на рідних. Своїх переживань розкривати не хоче, від психотерапевтичної допомоги відмовляється, але погоджується приймати ліки. Який препарат доцільно призначити пацієнту?

- A. Вальпроат натрію
- B. Сертралін
- C. Сульпірид
- D. Прегабалін
- E. Кветіапін

143. Який основний елемент лікування отруєння метиловим спиртом?

- A. Детоксикація
- B. Підтримання серцевої діяльності
- C. Введення стилового етириту
- D. Форсований діурез
- E. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

144. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 10-ти років перебувала в державній психіатричній лікарні. Більшу частину дня проводить гоїдаючись,

тихо бурмочучи собі під ніс або дивлячись на своє відображення в маленькому дзеркалі. Їй потрібна допомога з одяганням і прийняттям душ, вона часто хіхікає і сміється без видимої причини. Який найімовірніший діагноз?

- A. Біполярний розлад, маніакальна фаза
- B. Маячний розлад
- C. Шизофреноформний розлад
- D. Шизоафективний розлад
- E. Шизофренія

145. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 16 років із дванадцятирічного віку змінився в поведінці, став «дурником», часто неадекватним у поведінці та емоціях, бував деструктивним, спостерігалася розірваність мовлення та мислення. Для якого патологічного розладу характерна така симптоматика?

- A. Гебефренної шизофренії
- B. Параноїдної шизофренії
- C. Кататонічної шизофренії
- D. Шизоафективного розладу
- E. Біполярного афективного розладу

146. Пацієнтку віком 70 років шпиталізовано до опікового відділення з опіками третього ступеня 35% тіла через пожежу в будинку. Ввечері на 4-ий день перебування в лікарні вона дістає свою крапельницю та починає кричати, що люди намагаються її поранити. Через кілька годин виявляється, що їй важко розбудити та вона дезорієнтована. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Поява основної деменції
- B. Короткочасний реактивний психоз
- C. Гострий стресовий розлад
- D. Гострий маніакальний епізод
- E. Делірій

147. Пацієнтка віком 68 років послизнулася на кризі та вдарилася головою. Протягом наступних 3-х тижнів у неї з'являється постійний головний біль, вона стає все більш розсіяною та забудькуватою, а вночі наляканою та дезорієнтованою. Яка найімовірніша причина цієї симптоматики?

- A. Епідуральна гематома
- B. Мультиінфарктна деменція
- C. Менінгіома лобової частки
- D. Хвороба Корсакова
- E. Субдуральна гематома

148. Який із нижченаведених варіантів депресії не належить до тих, що можуть бути асоційовані з COVID-19?

- A.** Постпшизофренічна
- B.** Біполярна
- C.** Рекурентна
- D.** Органічна
- E.** Короткотривала депресивна реакція

149. Пацієнтка віком 32 роки звернулася вперше до лікаря-психіатра зі скаргою на «провал у пам'яті», який, за її словами, стався з нею вперше в житті. Зазначає, що сьогодні раптово дізналася, що ~~тиждень перебувала~~ за кордоном, відвідуючи маму похилого віку, а повернулася 2 дні тому: з подивом для себе виявила відмітки в паспорті про в'їзд і виїзд, квитки, переписку з мамою і друзями щодо поїздки. Зовсім не пам'ятає ані обставин, ані часу, ані самого факту подорожі. Пацієнтка розповіла, що 2 тижні тому посварилася з чоловіком, він поведився агресивно, погрожував, шантажував. За словами знайомих, через кілька днів вона раптово вирішила поїхати до мами за кордон. Виглядала напруженою, тривожною, «заклопотаною». На момент огляду: орієнтована всебічно правильно, свідомість ясна, психопродуктивна симптоматика відсутня, емоційно лабільна, тривожна,

місцями демонстративна поведінка. Не може згадати жодної події чи факту з періоду після сварки і до повернення додому. Пам'ять на основні важливі події в минулому, імена, дати, обличчя, місця, а також на поточні події і короткострокова пам'ять без грубих порушень. Когнітивні функції в нормі. Неврологічний стан без патології. МРТ, КТ, ЕЕГ — без патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Кореяковський синдром
- B.** Дисоціативна амнезія
- C.** Ретардована амнезія
- D.** Фіксаційна амнезія
- E.** Делірій

150. Укажіть принцип, за яким в Україні не надається психіатрична допомога під час планової шпиталізації.

- A.** Додержання прав людини та громадянина
- B.** Недобровільності
- C.** Доступності до сучасного рівня наукових знань
- D.** Гуманності
- E.** Необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних послуг

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО
ІСПИТУ КРОК 3 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХІАТРІЯ»**

Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України»

Підписано до друку 01.05.2025 № 01/02/34. Формат 60x84 1/8
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Суг. Друк офсет.
Ум. друк. арк. 24. Облік. вид. арк. 28.